

Laporan Analisis Sintesis & Evaluasi Kebijakan

Audit Strategis Eksekutif & Peta Jalan Inovasi Digital Stunting Indonesia



Dekonstruksi Paradoks Sosio-Ekonomi,
Kesenjangan Intervensi Digital, dan Optimalisasi
UX Kader Posyandu (2023–2026).

Target Global WHO ($< 20\%$)

Standar batas toleransi prevalensi stunting yang ditetapkan oleh World Health Organization.

Realitas Nasional SSGI/SKI (21,5% - 24,4%)

Stagnasi penurunan prevalensi di lapangan. Kegagalan konvergensi intervensi pada target spesifik dan sensitif.

Execution Gap: *Research Gap & App Abandonment*

Titik kegagalan operasional. Inovasi teknologi (mHealth) tidak diterjemahkan menjadi adopsi berkelanjutan di tingkat akar rumput.

Purpose (Tujuan Riset)



Eksploratif ke Eksplanatori

Pemetaan transisi dari sekadar identifikasi faktor risiko menuju penjelasan mengapa intervensi digital (seperti ELSIMIL) gagal dipertahankan oleh pengguna.

Nature (Sifat Investigasi)



Korelasi vs. Kausalitas

Mengisolasi dampak langsung desain offline-first terhadap presisi pencatatan data antropometri kader.

Time Horizon (Lini Masa)



Cross-Sectional & Longitudinal

Penggabungan data potong-lintang (survei kepuasan) dengan evaluasi kohort (retensi penggunaan 9 bulan pada KEPITING).

Manipulation (Pengendalian Variabel)



Ex-Post Facto & Quasi-Eksperimental

Analisis komparatif antara intervensi konvensional vs. pendampingan digital terpadu terbukti empiris.

Impact Dashboard

PICO Demographics

N=47.021

(Total Sampel Tinjauan)

Population: Ibu hamil, pengasuh balita, remaja putri, dan Kader Posyandu di area urban dan rural Indonesia.

Intervention: Adopsi aplikasi mHealth berbasis User-Centered Design (UCD) dan sistem Offline-First.

Comparison: Pencatatan konvensional (KMS kertas) dan aplikasi berat yang membutuhkan koneksi real-time.

The Operational Breakthrough

Reduksi Error Data Antropometri

Metode Manual/
Aplikasi Non-UX

15% Error Rate

Sistem UX-Optimized
& Offline-First

1,8% Error Rate

Takeaway: Desain antarmuka (UI/UX) bukan sekadar estetika; ia adalah determinan mutlak untuk validitas data surveilans stunting nasional.

Paradox Matrix: Asumsi Teoritis vs. Realitas Empiris

Asumsi Teoritis

The Educational Disconnect

Pendidikan formal ibu menjamin perbaikan gizi anak.

The Economic Misallocation Paradox

Kemiskinan adalah penyebab tunggal stunting.

Realitas Empiris

Pendidikan Formal ($p=0,458$) vs. Pengetahuan Gizi ($p=0,003$)

Status kelulusan tidak bermakna tanpa literasi spesifik tentang pencegahan stunting dan pola asuh.

22,6% Anak Stunting Berasal dari Keluarga Mampu

Kegagalan bukan pada daya beli, melainkan Misalokasi Ekonomi – pengeluaran bergeser pada makanan ultra-proses (UPF) dan jajanan minim gizi.

Executive Strategic Audit: Risk Factor Odds Ratios

Perawakan Ibu Pendek (<145 cm)

Cluster biologis & genetik

Pendapatan Rumah Tangga & Ketahanan Pangan

Risiko stunting meningkat 3,77 - 4,66 kali lipat pada area ekonomi ekstrem

Ketiadaan Akses WASH (Air & Sanitasi)

Risiko infeksi enterik kronis (OR > 2.0)

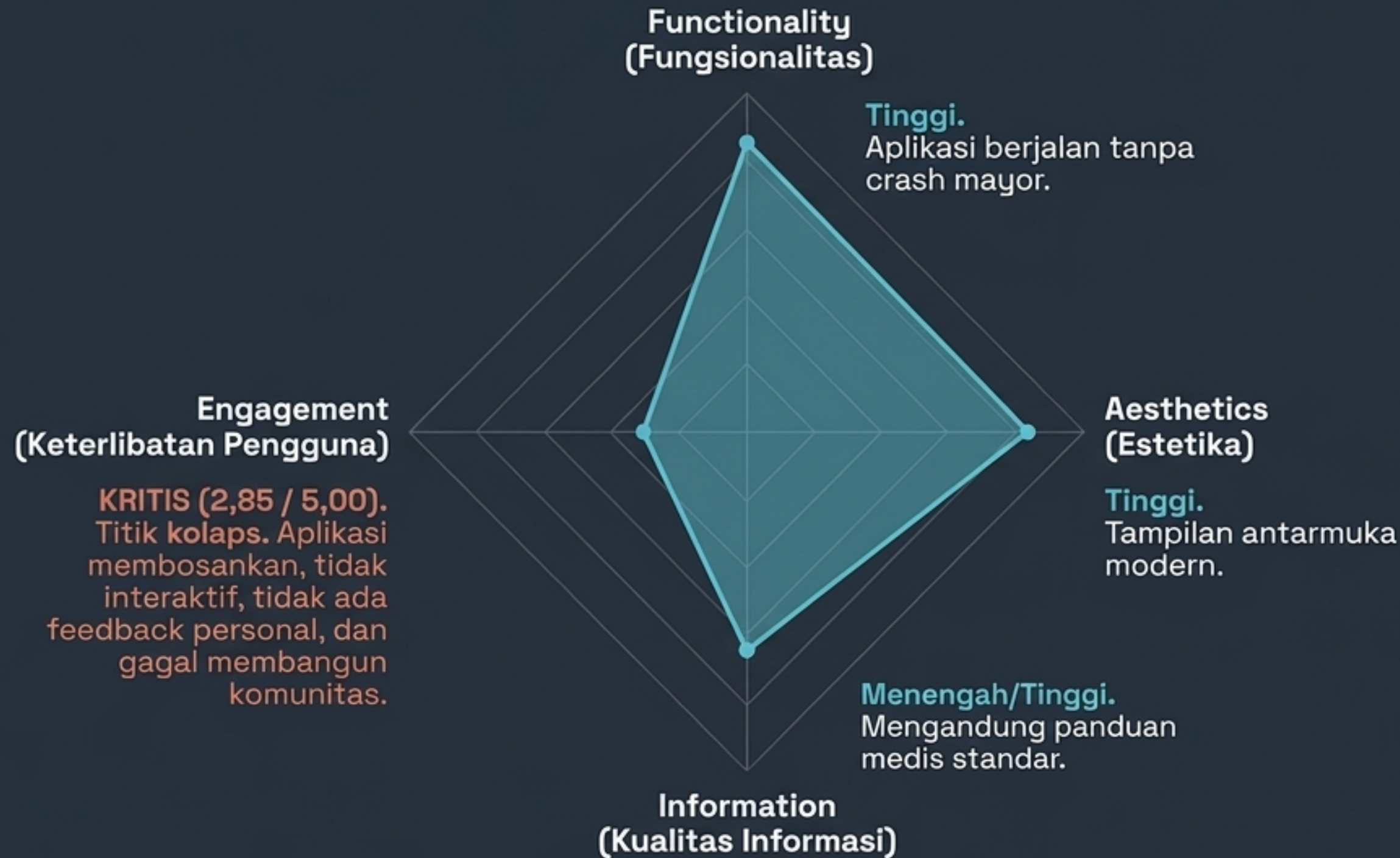
Kenaikan Berat Badan Gestasional Inadekuat

Malnutrisi pra-konsepsi dan masa kehamilan mendikte defisit awal



Intervensi digital harus menyorot titik-titik risiko dengan Odds Ratio tertinggi ini, bukan sekadar pelacakan berat badan pasca-lahir.

Digital App Performance Audit: The Engagement Collapse



The Engagement Collapse

Nilai 2,85 mengonfirmasi mengapa app abandonment menjadi hambatan utama dalam transformasi kesehatan digital Indonesia.

Beban Memori & RAM

Ukuran file aplikasi yang terlalu besar membebani **smartphone** spesifikasi rendah milik pengasuh dan kader, memicu **uninstall massal**.

Kompleksitas Akses (OTP Failures)

Sistem login yang kaku (kegagalan OTP, satu akun satu perangkat) menghalangi pelacakan data oleh keluarga secara kolektif.

Ketergantungan Sinyal (No Offline Sync)

Mewajibkan koneksi **real-time** di wilayah pedesaan/kepulauan menyebabkan kader **gagal input data** saat Posyandu berlangsung.

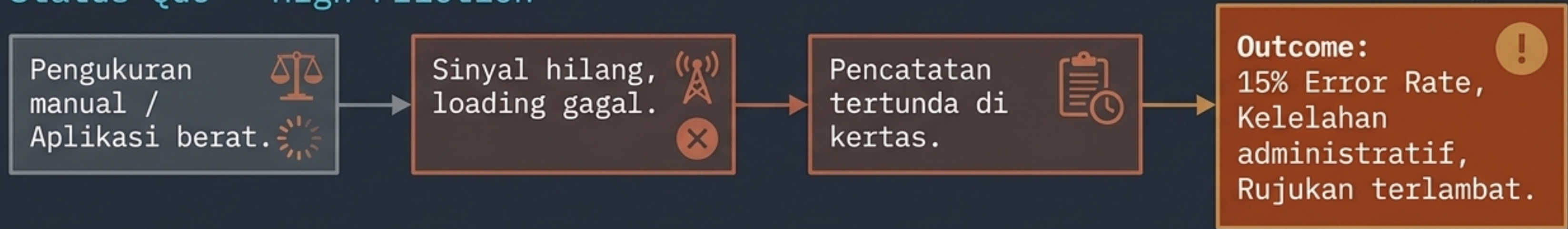
Beban Kognitif Kader

Usia kader yang bervariasi dengan literasi digital yang belum merata berbenturan dengan desain antarmuka yang terlalu teknis dan rumit.

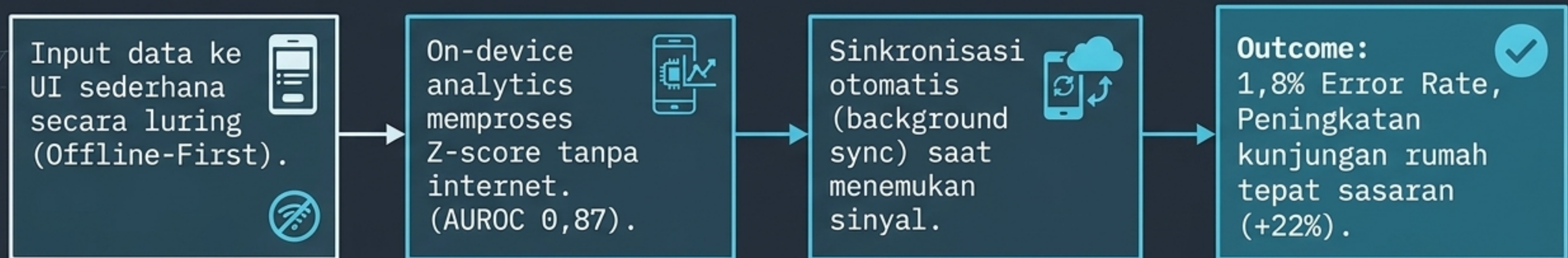


Optimized Cadre Operations: From High-Friction Status Quo to SiKurang Model Blueprint

Status Quo - High Friction



Optimized Blueprint - SiKurang Model



HOLISTIC STUNTING ECOSYSTEM

MACRO (TATA KELOLA DATA & INTEROPERABILITAS)

Kebijakan harus memastikan data dari aplikasi akar rumput terintegrasi lintas kementerian (Dinas Kesehatan, BKKBN) untuk mencegah **silo informasi**. 

MESO (OPTIMALISASI UX KADER POSYANDU)

Menjadikan kader sebagai ujung tombak dengan membekali mereka aplikasi berstandar User-Centered Design (ringan, luring, minim klik).

MICRO (KONTEKS SOSIO-EKONOMI KELUARGA)

Aplikasi untuk pengasuh tidak hanya melacak berat badan, tetapi menyediakan solusi MP-ASI terjangkau berdasar pangan lokal untuk mengatasi **Misalokasi Ekonomi (22,6%)**.



Transformasi digital gagal jika hanya memindahkan kertas ke layar. Digitalisasi harus menyederhanakan birokrasi dan menyesuaikan kemampuan sosio-ekonomi masyarakat.

2023

2024

2025

2026

Digitasi dasar
Peluncuran
aplikasi
sporadis

Identifikasi App
Abandonment
Konsolidasi data
Benchmarking MARS

Standardisasi
UI/UX Nasional
Implementasi
algoritma
Offline-First

Integrasi prediktif
(AI)
Interoperabilitas
sistem lintas
kementerian
real-time

Y-Axis

Postnatal
(Balita 0-59 Bulan)

Prenatal
(Kehamilan)

Preconception
(Remaja & Calon
Pengantin)

Shifting toward
preventative,
upstream stunting
intervention.